

Université de Constantine 2025

Faculté de médecine

3 ème année de médecine

Module de sémiologie de l'appareil génital féminin

Dr. A. Boudjeriou

Plan :

1) Rappel anatomique

2) Rappel physiologique

3) Etude sémiologique :

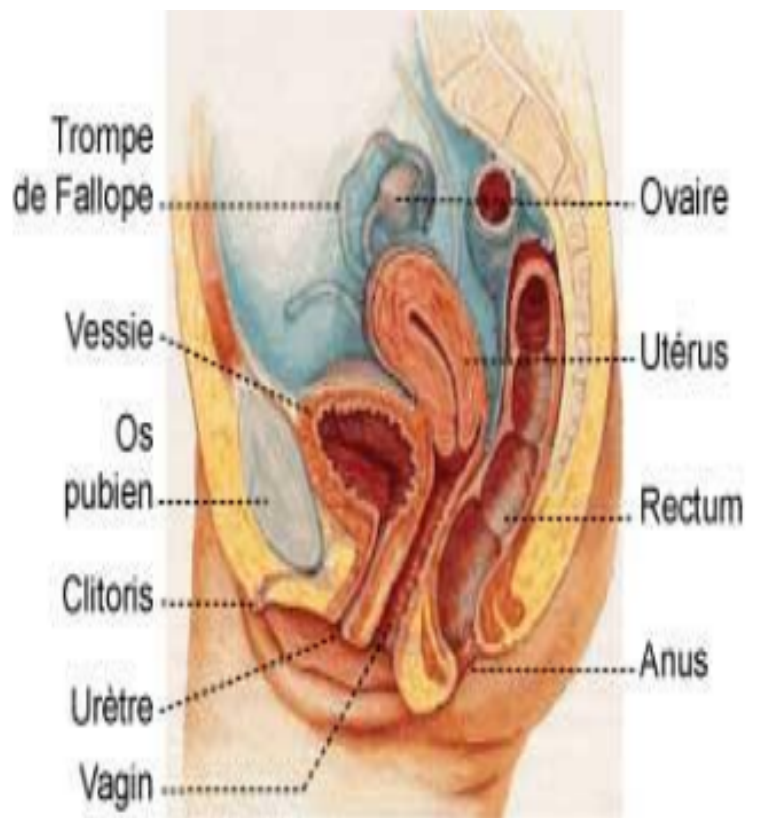
A/ interrogatoire

B) 'examen gynécologique

Objectifs :

- Connaître les principaux signes cliniques
- Faire un examen clinique minutieux
- Orienter les explorations selon la probabilité clinique

Rappel anatomique :



L'appareil génital féminin est constitué de :

- **Partie externe** : formée des grandes lèvres, des petites lèvres qui forment en avant le clitoris, séparées par le vestibule dont la portion postérieure forme l'ouverture du vagin.
- **Le périnée** est constitué des tissus qui séparent l'ouverture du vagin de l'anus.
- **Le méat urétral** débouche entre le clitoris et le vagin qui forme un tube creux dirigé en postérieur et vers le haut.
- **L'utérus** : fait saillie dans le vagin à travers le col. Il est formé de l'isthme

et du cœps d'où partent de chaque côté

- **les trompes de FALLOPE**, à extrémité frangée se repliant sur l'ovaire.

Les ovaires en forme d'amande de 1.5 à 3.5 cm.

2) RAPPEL PHYSIOLOGIQUE :

- **Puberté** : développement mammaire débute vers l'âge de 10 à 11 ans, Menstruation vers 12-13 ans.

- **Cycle menstruel** : dure 28 à 30 jours, se termine par les menstruations de 4 à 6 jours. Le cycle se divise en quatre phases :

* **Phase prè-ovulatoire** : du 5^e au 14 jour, de prolifération sous l'effet des œstrogènes.

* **Ovulation** : entre le 14^e et le 16^e jour. Provoquée par une décharge brutale de LH.

* **Phase post-ovulatoire** : du 17^e au 28^e jour, sous la dépendance de la progestérone.

*La menstruation est due à l'élimination de la muqueuse de l'endomètre et s'accompagne d'hémorragie.

- La période ovulatoire est caractérisée par une ascension thermique matinale au-delà de 37 degré.

- La sécrétion hormonale ovarienne en œstrogènes et en progestérone est sous la dépendance de stimulines antéhypophysaires FSH/LH.

3) Etude sémiologique :

A- Interrogatoire :

- Antécédents physiologiques :

- Ménarche : ou date des premières règles.
- Cycle menstruel : préciser la périodicité, la durée, l'abondance.
- Date des dernières règles (en cas de grossesse).
- Nombre de grossesses (enfants vivants, décédés, avortement, prématuré, mort né ...).
- Mode de contraception (oestroprogestatifs, DIU, ligature des trompes).
- Ménopause (disparition définitive des règles entre 45 et 55ans).

Les antécédents pathologiques :

- hystérectomie, intervention pour kyste de l'ovaire, césarienne, des antécédents d'infection génitale, tuberculose, néoplasie (cancer du sein ou du col...).

Signes fonctionnels :

1) Les douleurs :

- Douleur pelvienne de siège hypogastrique, fosse iliaque, voir lombaire associée.
- Dyspareunie ou douleur du petit bassin lors des rapports sexuels, fonctionnelle ou révélant une cause organique

2) Les pertes vaginales ou leucorrhées :

Blanchâtre : avec prurit et rougeur vulvaire et vaginale à l'examen d'origine mycosique (candida albicans).

- Blanc jaunâtre : odorante avec piqueté rouge cervical et vaginal due au trichomonas vaginal.
- Purulente jaunâtre ou verdâtre : d'origine bactérienne.
- Transparentes : physiologiques survenant avant l'ovulation.

c) Les hémorragies génitales :

1-Hémorragie non extériorisée : urgence, liée à la rupture d'une grossesse extra-utérine, donnant un hème-péritoine avec risque d'état de choc.

L'examen retrouve la notion de pertes noirâtres, sensibilité hypogastrique, avec douleur du cul de sac du Douglas.

2-Hémorragies extériorisées : sont des pertes sanglantes

➤ **suivant leur date de survenue par rapport aux règles**

- Les ménorragies : règles trop abondantes ou trop prolongées (fibrome).
- Les métrorragies : hémorragie en dehors des règles spontanées ou provoquées (cancer génital).
- Les méno-métrorragies : des règles abondantes ou prolongées et des hémorragies génitales en dehors des règles.

d) troubles de la menstruation :

- **Pollakiménorrhée** : règles trop rapprochées par raccourcissement de la durée du cycle.

- **Spanioménorrhée** : règles trop espacées par allongement de la durée du cycle.

- **Oligoménorrhée** : règles trop courtes.

- **Oligo-spanioménorrhée** : règles trop courtes et trop espacées

- **Aménorrhée** : absence de règles pendant la période génitale active.

* Aménorrhée primaire : par absence de ménarchie.

* Aménorrhée secondaire : après une de menstruation normale, évoque en 1er une grossesse, synéchie utérine après curetage, tuberculose, pathologie générale, psychique....

-Dysménorrhée ou menstruations douloureuses : la douleur précède ou est contemporaine du cycle.

B- Examen gynécologique :

1. Les conditions de l'examen :

- La malade doit être examinée : sur une table gynécologique en décubitus dorsal, les cuisses demi fléchies, en abduction, les jambes fléchies.
- Il est indispensable que la malade vide préalablement sa vessie et son rectum.
- Le matériel nécessaire est le suivant : un spéculum et un doigtier à deux doigts stérile, un produit lubrifiant.

2. Conduite de l'examen :

a. L'inspection :

Va apprécier les caractères sexuels secondaires :

- Les seins
- la pilosité axillaire, la pilosité pubienne qui est triangulaire
- et les organes génitaux externes :
 - les grandes lèvres sont normalement charnues,
 - les petites lèvres sont pigmentées et humides.

b) **Palpation** : recherche une zone douloureuse de la région sus pubienne ou de la fosse iliaque, ainsi qu'une masse abdomino-périnéale.

c) **Percussion** : utile dans les tumeurs abdomino-périnéales, différencie un kyste ovarien d'un épanchement d'ascite abdominale.

d) **L'examen au spéculum** : doit précéder le toucher vaginal, permet apprécier l'aspect du col de l'utérus.

Il permet d'apprécier l'aspect du col de l'utérus.

- Sa situation : centrale ou déviée latéralement.

- Sa forme : conique chez la nullipare, cylindrique chez la multipare, atrophique chez la femme ménopausée.
- Son orifice externe : recherche de lésion traumatique à type de déchirure, d'érosions : qui sont le signe d'une exocervicite, d'ulcérations ou tumeur proliférante.

L'examen au speculum permet aussi de réaliser :

- Frottis vaginaux : étaler sur une lame des cellules desquamées du col et du vagin et à les examiner au microscope.
- Colposcopie : examen à la loupe binoculaire après application du lugol (test de SCHILLER), le col est de coloration brun acajou, les zones suspectes sont roses, blanchâtres ou jaunâtres.
- Biopsie du col en cas de lésion suspecte.

e) **Toucher vaginal** : avec doigtier stérile à 02 doigts (index et le majeur) plus lubrifiant.

***Etat du col** : situation, consistance normalement souple, ferme et élastique.

*** Cul de sacs vaginaux** : latéraux et postérieur, apprécier la souplesse et la vacuité.

***Combiné à la palpation abdominale** : Apprécie la taille de l'utérus, consistance et sensibilité, ainsi que l'exploration des annexes (ovaires)

***Combiné au toucher rectal**, le toucher vaginal apprécie état de la cloison recto vaginale.

- L'aspect du doigtier est normalement propre. Il peut être souillé de sang ou de leucorrhées.

****Chez la jeune fille**, le toucher rectal remplace le toucher vaginal.